ورقة مراجعة مكتبة ECG

39 نمط — مصنفة حسب الخطورة، للمساعدة التعليمية فقط

هذه الورقة تعليمية ومرجعية فقط، والأشكال تخطيطية مبسطة وليست تسجيلات حقيقية.
لا تُستخدم بديلاً عن تفسير ECG الفعلي للمريض أو تقييم الطبيب.

طريقة القراءة

- رسمة صغيرة توضح شكل الموجة العام (مش تسجيل حقيقي)
- الاسم بالعربي والإنجليزي
- المعدل التقريبي (نبضة/دقيقة)
- ★ أهم Memory Trick لتثبيت النمط في دماغك



الإيقاع الجيبي الطبيعي
Normal Sinus Rhythm

Normal المعدل: 60-100 bpm

★ موجة P تسبق كل QRS بانتظام

المحتويات حسب الخطورة

- مميت — 3 نمط
- حرج — 11 نمط
- عاجل — 11 نمط
- مراقبة — 11 نمط
- طبيعي — 3 نمط

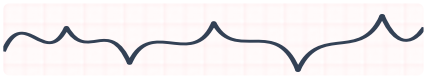
مميت

3 patterns

الإيقاع المسطح (توقف القلب)
Asystole

CPR المعدل: 0 bpm

★ المريض على خط مسطح! Assist Fully



الرجفان البطيني (خشن)
Coarse Ventricular Fibrillation

CPR / Shock المعدل: — bpm

★ خط متعرج فوضوي — Fib is flopping



النشاط الكهربائي بلا نبض (PEA)
Pulseless Electrical Activity

CPR المعدل: متغير bpm

★ شاشة منظمة... لكن لا نبض حقيقي

حرج

11 patterns



التواء الأطراف (Torsades de Pointes)

Torsades de Pointes

CPR / Shock — المعدل: bpm 200-250

★ دوامة ملتفة حول الخط — Tornado Pointes



تسرع القلب البطيني (أحادي الشكل)

Monomorphic Ventricular Tachycardia

CPR / Shock — المعدل: bpm 100-250

★ شكل شاهد القبر — V Tach Tombstone pattern



الرجفان البطيني (ناعم)

Fine Ventricular Fibrillation

CPR / Shock — المعدل: — bpm

★ شبيه بالمسطح لكنه ليس كذلك — تحقق دائماً من التوصيلات



الإحصار الأذيني البطيني الكامل (الدرجة 3)

Complete (3rd-Degree) Heart Block

Pacemaker — المعدل: متغير bpm

★ موجات P و QRS كل واحد ماشي لوحده



احتشاء بارتفاع ST (STEMI)

ST-Elevation Myocardial Infarction

Cath Lab — المعدل: متغير bpm

★ ST مرتفع جداً = عضلة قلب بتموت الآن



تغيرات ECG في فرط بوتاسيوم الدم

Hyperkalemia ECG Changes

Calcium Gluc. — المعدل: متغير bpm

★ موجة T مدببة وضيقة = بوتاسيوم عالي



احتشاء بدون ارتفاع ST / ذبحة غير مستقرة

NSTEMI / Unstable Angina

Labs/Meds — المعدل: متغير bpm

★ بدون ارتفاع ST — لازم إنزيمات القلب تفرق الحالة



احتشاء عضلة القلب الحاد الجانبي

Acute Lateral Wall MI (STEMI)

Cath Lab — المعدل: متغير bpm

★ ارتفاع ST في I و aVL و V5-V6 = جانبي



احتشاء عضلة القلب الحاد الأمامي

Acute Anterior Wall MI (STEMI)

Cath Lab — المعدل: متغير bpm

★ V1-V4 = أمامي = LAD = الأخطر



احتشاء عضلة القلب الحاد السفلي

Acute Inferior Wall MI (STEMI)

Cath Lab — المعدل: متغير bpm

★ II و III و aVF = سفلي = راقب بطء القلب



نمط ECG في الانسداد الرئوي

Pulmonary Embolism ECG Pattern (S1Q3T3)

CT / Meds — المعدل: متغير (غالباً تسرع) bpm

★ S1Q3T3 — غير نوعي لكنه مشير للانسداد الرئوي

عاجل

11 patterns



الإحصار من الدرجة الثانية (موبيتز 2)

2nd-Degree AV Block, Type II (Mobitz II)

Pacer Prep — المعدل: متغير bpm

★ إسقاط منتظم للـQRS — النمط ثابت ومتوقع



رجفان أذيني بمعدل بطيني سريع (AFib RVR)

Atrial Fibrillation with RVR

Meds / Cardiovert — المعدل: bpm 100-175

★ No P wave = Fibrillation Flopping

تسرع فوق البطيني (SVT)

Supraventricular Tachycardia

Vagal / Adenosine — المعدل: bpm 150-250

★ Super fast = Supraventricular



متلازمة QT القصير

Short QT Syndrome

Monitor — المعدل: طبيعي bpm

★ QT قصير جداً = خطر VF نادر لكن خطير



نقص تروية عضلة القلب (انخفاض ST)

Myocardial Ischemia (ST Depression)

O2 / Nitro — المعدل: متغير bpm

★ ST منخفض = القلب تعبان لكن لسه ماماتش



رفرفة أذينية (Atrial Flutter)

Atrial Flutter

Meds — المعدل: غالباً حوالي 150 bpm

★ A Flutter = Sawtooth (شكل سن المنشار)



تغيرات ECG في نقص بوتاسيوم الدم

Hypokalemia ECG Changes

KCl Repl. — المعدل: متغير bpm

★ T مسطحة + U واضحة = بوتاسيوم واطي



نمط ECG في التهاب التأمور

Pericarditis ECG Pattern

NSAIDs — المعدل: متغير bpm

★ ارتفاع ST منتشر في كل الـLeads تقريباً



تسرع الأذيني متعدد البؤر (MAT)

Multifocal Atrial Tachycardia

Treat Cause — المعدل: bpm 100-180

★ 3 أشكال مختلفة لموجة P على الأقل

متلازمة QT الطويل

Long QT Syndrome

Monitor — المعدل: متغير bpm

★ QT طويل = القلب مستني وقت أطول قبل الضربة



تغيرات ECG في نقص كالسيوم الدم

Hypocalcemia ECG Changes

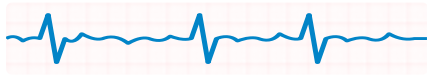
Calcium Repl. — المعدل: متغير bpm

★ ST طويل = السبب غالباً كالسيوم واطي



مراقبة

11 patterns



رجفان أذيني بمعدل متحكم

Atrial Fibrillation, Rate-Controlled

Monitor — المعدل: bpm 60-100

★ No P wave لكن المعدل طبيعي



الإحصار من الدرجة الأولى
1st-Degree AV Block

Monitor — المعدل: bpm 60-100

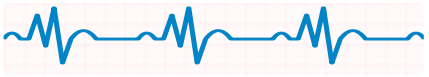
★ PR interval طويل وثابت فقط — لا إسقاط للـQRS



الإحصار من الدرجة 2 (النوع الأول — فينكباخ)
2nd-Degree AV Block, Type I (Wenckebach)

Monitor — المعدل: bpm متغير

★ PR بيطول... بيطول... لحد ما يسقط ضربة



إحصار الحزمة اليمنى (RBBB)
Right Bundle Branch Block

Assess — المعدل: bpm 60-100

★ شكل M أو أذنين أرنب في V1



إحصار الحزمة اليسرى (LBBB)
Left Bundle Branch Block

Assess — المعدل: bpm 60-100

★ LBBB جديد + ألم صدر = عامله زي الاحتشاء



الإيقاع العقدي (Junctional Rhythm)
Junctional Rhythm

Assess — المعدل: bpm 40-60

★ P wave غائبة أو مقلوبة — العقدة اللي بتتحكم



انقباضات بطينية مبكرة (PVCs)
Frequent Premature Ventricular Contractions

Monitor — المعدل: bpm متغير

★ نبضة مبكرة واسعة وسط إيقاع منتظم



تسرع الجيوب الأنفية
Sinus Tachycardia

Treat Cause — المعدل: bpm 100-150

★ شكل جيبي طبيعي لكن أسرع



بطء الجيوب الأنفية
Sinus Bradycardia

Assess — المعدل: bpm أقل من 60

★ BRADYcardia = أقل من 60



متلازمة وولف-باركنسون-وايت (WPW)
Wolff-Parkinson-White Syndrome

Referral — المعدل: bpm 60-100 (أو تسرع)

★ Short PR + Wide QRS + Delta wave

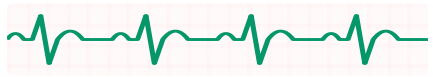


إيقاع المنظم الكهربائي (Paced Rhythm)
Paced Rhythm

Monitor — المعدل: bpm حسب الجهاز

★ خط رأسي حاد (Spike) قبل QRS عريض

طبيعي
3 patterns



الإيقاع الجيبي الطبيعي
Normal Sinus Rhythm

Normal — المعدل: bpm 60-100

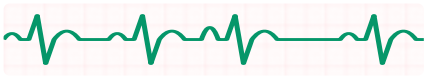
★ منتظم ومتباعد بالتساوي وموجة P موجودة



عدم انتظام الإيقاع الجيبي
Sinus Arrhythmia

Normal — المعدل: bpm 60-100

★ المعدل يتغير مع التنفس — طبيعي تماماً



الانقباض الأذيني المبكر (PAC)
Premature Atrial Contraction

Normal — المعدل: bpm طبيعي

★ ضربة مبكرة ضيقة بموجة P مختلفة الشكل